

TAROMENTIN

(Bột pha hỗn dịch uống Amoxicillin 400mg/5ml + Clavulanic acid 57mg/5ml)

1. Các dấu hiệu lưu ý và khuyến cáo khi dùng thuốc

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng
Để xa tầm tay trẻ em

2. Thành phần công thức thuốc

Mỗi ml hỗn dịch uống sau khi pha có chứa:

Hoạt chất: Amoxicillin trihydrat tương đương

Amoxicillin.....80 mg

(tương ứng 400 mg Amoxicillin/5 ml hỗn dịch sau khi pha)

Kali clavulanat tương đương Clavulanic acid.....11,4 mg

(tương ứng 57 mg Clavulanic acid/5ml hỗn dịch sau khi pha)

Tá dược: Guar gum, silicon dioxit, silic keo khan, trinitrat citrat khan, acid citric khan, aspartam, hương cam, hương hoa quả nhiệt đới, hương chanh.

3. Dạng bào chế

Bột pha hỗn dịch.

Mô tả dạng bào chế: bột pha hỗn dịch màu trắng đến vàng nhạt, sau khi pha với nước thu được một hỗn dịch đồng nhất.

4. Chỉ định

Taromentin được sử dụng ở trẻ sơ sinh, trẻ em và người lớn trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn sau đây:

- Viêm tai giữa và viêm xoang cấp tính do vi khuẩn
- Nhiễm khuẩn đường hô hấp
- Nhiễm khuẩn đường tiêu hóa
- Nhiễm khuẩn da và mô mềm, bao gồm cả nhiễm khuẩn trong nha khoa
- Nhiễm khuẩn xương và khớp

5. Cách dùng, liều dùng

Thuốc dùng đường uống.

Liều dùng:

Hỗn dịch thường được khuyến cáo không dùng cho người lớn và trẻ em cân nặng hơn 40 kg.

Trẻ em cân nặng dưới 40 kg

Tất cả các liều được xác định tùy thuộc vào trọng lượng (kg) của bệnh nhân.

Liều thông thường: từ 28,6 mg – 51,4 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, chia thành 2 liều.

Liều lớn hơn: từ 80 mg cho mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, chia thành 2 liều.

Mỗi hộp có chứa một muỗng có vạch mức 1,25 ml, 2,5 ml và 5 ml, ngoài ra còn có một ống tiêm. Nên sử dụng những dụng cụ này để đảm bảo dùng đúng liều.

Bệnh nhân có vấn đề về thận và gan

Bệnh nhân suy thận: có thể cần thay đổi liều hoặc thay đổi loại thuốc dựa theo chỉ định của bác sĩ.

Không yêu cầu điều chỉnh liều đối với bệnh nhân có độ thanh thải thận (CrCl) lớn hơn 30ml/phút.

Ở những bệnh nhân có độ thanh thải thận dưới 30 ml/phút, không khuyến cáo dùng Taromentin có tỷ lệ amoxicillin và clavulanic acid trong công thức là 7:1 do thiếu các khuyến cáo liên quan về thay đổi liều.

Các triệu chứng cần thận trọng khi sử dụng

Taromentin: Việc sử dụng Taromentin có thể gây tình hình xấu hơn hoặc gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng bao gồm cả phản ứng dị ứng, co giật và viêm ruột già. Cần thận trọng để ý tới các triệu chứng trong khi sử dụng Taromentin, để giảm nguy cơ xấu xảy ra.

Xét nghiệm máu và nước tiểu: Taromentin có thể ảnh hưởng đến kết quả của các loại xét nghiệm máu (chẳng hạn như thử nghiệm tế bào hồng cầu hoặc xét nghiệm chức năng gan) hoặc xét nghiệm nước tiểu (để kiểm tra glucose).

Taromentin chứa aspartam, là một phenylamin. Nó có thể làm cho trẻ em sinh ra có nguy cơ mắc bệnh “phenylketonuria”, một rối loạn di truyền hiếm gặp trong đó phenylalanin bị tích lũy do cơ thể không thể thải trừ đúng cách.

8. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú

Không có dữ liệu về sử dụng thuốc trên phụ nữ có thai và cho con bú, chỉ nên dùng thuốc nếu lợi ích vượt trội so với nguy cơ. Cần tư vấn bác sĩ khi đang mang thai hoặc cho con bú, hoặc đang có kế hoạch mang thai.

9. Ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc

Chưa có bằng chứng về sự ảnh hưởng của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc.

10. Tương tác, tương kỵ thuốc

Tương tác thuốc

Sử dụng cùng với allopurinol (điều trị bệnh Gout), các phản ứng dị ứng trên da có thể xảy ra với khả năng cao hơn.

Sử dụng cùng với probenecid (điều trị bệnh Gout), nên tham khảo ý kiến bác sĩ để điều chỉnh liều Taromentin. Sử dụng cùng với các thuốc giảm đông máu (như warfarin), nên làm xét nghiệm lại máu.

Taromentin có thể ảnh hưởng đến tác dụng của methotrexat (thuốc điều trị ung thư hoặc bệnh thấp khớp).

Tương kỵ thuốc

Do không có nghiên cứu về tính tương kỵ của thuốc, không trộn lẫn thuốc này với các thuốc khác.

11. Tác dụng không mong muốn của thuốc

Taromentin có thể gây ra tác dụng phụ, mặc dù không phải cho tất cả mọi người. Có thể xảy ra các tác dụng phụ được liệt kê dưới đây:

Phản ứng quá mẫn:

- Nổi mẩn trên da
- Viêm mạch máu có thể làm xuất hiện màu đỏ hoặc tím trên da, nhưng có thể ảnh hưởng đến cơ quan khác
- Sốt, đau khớp, sưng hạch ở cổ, nách hoặc háng
- Sưng tấy, đôi khi ở mặt hoặc khu vực miệng (phù mạch), gây ra khó thở
- Ngất xỉu

Liên hệ với các bác sĩ ngay lập tức nếu có các triệu chứng này xảy ra và ngưng sử dụng Taromentin.

Viêm ruột già

Viêm đại tràng, gây tiêu chảy thường có máu và chất

Bệnh nhân có vấn đề về gan cần được xét nghiệm máu thường xuyên hơn để kiểm tra chức năng gan.

Cách dùng

Dùng trước khi ăn.

Duy trì liều dùng hàng ngày cách nhau ít nhất 4 tiếng.

Không dùng 2 liều liên tiếp trong 1 giờ.

Không dùng Taromentin (400 mg + 57 mg)/5 ml cho trẻ em trong thời gian quá 2 tuần. Nếu bệnh không thuyên giảm, cần tham khảo ý kiến bác sĩ thêm một lần nữa.

Cách pha hỗn dịch: Trước khi đổ nước, lắc lọ để làm tơi bột.

Đổ nước đã đun sôi để nguội vào lọ chứa 6,3 g bột, đến vạch đánh dấu trên nhãn lọ (31 ml).

Lắc đều đến khi tạo hỗn dịch đồng nhất. Để lọ đứng yên và thêm nước vào đến vạch đánh dấu trên nhãn lọ (nếu cần thiết) để thu được 35 ml hỗn dịch.

Đổ nước đã đun sôi để nguội vào lọ chứa 12,6 g bột, đến vạch đánh dấu trên nhãn lọ (62 ml).

Lắc đều đến khi tạo thành hỗn dịch đồng nhất. Để lọ đứng yên và thêm nước vào đến vạch đánh dấu trên nhãn lọ (nếu cần thiết) để thu được 70 ml hỗn dịch.

Đổ nước đã đun sôi để nguội vào lọ chứa 25,2 g bột, đến vạch đánh dấu trên nhãn lọ (124 ml).

Lắc đều đến khi tạo thành hỗn dịch đồng nhất. Để lọ đứng yên và thêm nước vào đến vạch đánh dấu trên nhãn lọ (nếu cần thiết) để thu được 140 ml hỗn dịch.

5 ml hỗn dịch sau khi pha có chứa 400 mg amoxicillin và 57 mg clavulanic acid.

2,5 ml hỗn dịch sau khi pha có chứa 200 mg amoxicillin và 28,5 mg clavulanic acid.

1,25 ml hỗn dịch sau khi pha có chứa 100 mg amoxicillin và 14,25 mg clavulanic acid.

Lắc kỹ chai trước mỗi khi dùng.

Hỗn dịch sau khi pha phải được bảo quản trong tủ lạnh (2°C-8°C), dùng trong vòng 7 ngày sau khi pha.

Không vứt bất kỳ sản phẩm thuốc nào qua hệ thống nước thải hoặc rác thải gia đình. Tham khảo ý kiến bác sĩ về cách vứt bỏ các sản phẩm thuốc không còn dùng. Những biện pháp này góp phần bảo vệ môi trường.

Nếu bạn quên một liều thuốc: dùng ngay khi bạn nhớ ra. Liều tiếp theo nên dùng sau 4 tiếng, không nên dùng quá sớm.

Taromentin nên được dùng cho đến khi kết thúc điều trị, kể cả khi triệu chứng của bệnh đã được cải thiện. Mỗi liều thuốc đều có tác dụng kháng khuẩn. Một số vi khuẩn sống sót có thể gây tái phát nhiễm khuẩn.

6. Chống chỉ định

- Dị ứng (mẫn cảm) với amoxicillin, acid clavulanic hoặc bất kỳ thành phần nào khác của Taromentin.
- Bị dị ứng nặng (quá mẫn) với bất kỳ kháng sinh khác. Bao gồm phát ban da hoặc sưng mặt hoặc cổ.
- Có vấn đề về gan hoặc vàng da liên quan đến việc sử dụng kháng sinh.

7. Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc

Hỏi ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng Taromentin nếu có các hiện tượng sau:

- Sốt hạch
- Đang điều trị bệnh gan hoặc thận
- Không đi tiểu thường xuyên

nhầy, đau bụng và/hoặc sốt

Ngay lập tức liên hệ với bác sĩ điều trị để được tư vấn nếu có các triệu chứng này xảy ra

Tác dụng phụ rất phổ biến

Tiêu chảy (ở người lớn)

Tác dụng phụ phổ biến

- Nhiễm nấm (Candidosis- nhiễm nấm âm đạo, miệng hoặc các nếp gấp da)
- Cảm giác ốm, đặc biệt là khi dùng liều cao
- Nôn mửa
- Tiêu chảy (ở trẻ em)

Nếu các triệu chứng xảy ra, hãy dùng Taromentin trước khi ăn.

Tác dụng phụ không phổ biến

- Nổi mẩn trên da, ngứa.
- Nổi mẩn ngứa (phát ban)
- Chứng khó tiêu
- Chóng mặt
- Đau đầu

Tác dụng phụ không phổ biến có biểu hiện trong các kết quả xét nghiệm máu:

- Tăng hoạt động của một số enzym sản xuất bởi gan

Tác dụng phụ hiếm gặp

- Nổi mẩn trên da, có thể phỏng lên.
- Tác dụng phụ hiếm gặp có thể biểu hiện trong các kết quả xét nghiệm máu
- Số lượng thấp của các thể bào liên quan đến đông máu
- Số lượng thấp của các tế bào máu trắng.

Tác dụng phụ khác

Tác dụng phụ khác xảy ra ở một số ít người với tần số chưa được xác định

- Phản ứng quá mẫn
- Viêm ruột già
- Phản ứng da nghiêm trọng
 - + Phát ban da với mụn nước và bong tróc da, đặc biệt là xung quanh miệng, mũi, mắt và bộ phận sinh dục (hội chứng Steven-Johnson), và một dạng nặng hơn, gây bong da rộng (hơn 30% bề mặt cơ thể, hoại tử biểu bì da)
 - + Phát ban da đỏ với mụn mủ nhỏ (viêm da tróc vảy có bóng nước)
 - + Đỏ, có vảy phát ban với những bثور dưới da và mụn nước (Hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính)
- Viêm gan
- Vàng da, gây ra bởi sự tăng bilirubin (một chất được sản xuất trong gan) trong máu, có thể gây vàng da và mắt.
- Viêm ống thận
- Kéo dài thời gian đông máu
- Hiếu động thái quá
- Co giật (ở những người dùng liều cao Taromentin hoặc những người có vấn đề về thận).
- Lưỡi đen như mực lông.
- Răng nhuộm màu (ở trẻ em), có thể loại bỏ bằng cách thường xuyên đánh răng.

Tác dụng phụ có thể biểu hiện trong kết quả xét nghiệm máu hoặc nước tiểu:

- Giảm đáng kể số lượng các tế bào bạch cầu.
- Giảm số lượng các tế bào hồng cầu (thiếu máu tan huyết)
- Tinh thể trong nước tiểu

Nếu xảy ra bất kỳ tác dụng không mong muốn trong quá trình sử dụng, cần phải liên hệ với bác sĩ điều trị ngay.

12. Quá liều và cách xử trí

Triệu chứng:

Khi sử dụng quá liều Taromentin, có thể xảy ra các triệu chứng như dạ dày và kích thích ruột (cảm thấy khó chịu, nôn mửa và tiêu chảy) hoặc co giật.

Xử trí khi quá liều:

Không có thuốc giải độc đặc hiệu. Trong trường hợp ngộ độc, điều trị triệu chứng được thực hiện dựa trên việc theo dõi cân bằng điện giải và áp dụng các biện pháp phụ trợ thích hợp khác. Thuốc được loại ra khỏi tuần hoàn bằng phương pháp thẩm tách máu.

13. Đặc tính dược lực học

Nhóm dược lý: kháng khuẩn, sự kết hợp của penicillin, bao gồm các thuốc ức chế beta-lactamase.

Mã ATC: J01CR02

Cơ chế tác dụng:

Amoxicillin là một penicillin bán tổng hợp (kháng sinh beta-lactam) ức chế một hoặc nhiều các enzym (thường được gọi là protein gắn penicillin, PBPs) trong quá trình tổng hợp peptidoglycan của vi khuẩn, mà là một phần không thể thiếu của cấu trúc tế bào vi khuẩn. Ức chế tổng hợp peptidoglycan dẫn đến sự suy yếu của thành tế bào, mà thường là ly giải tế bào và chết vi khuẩn.

Amoxicillin dễ bị phân hủy bởi beta-lactamase, là enzym được tạo ra bởi sự đề kháng của vi khuẩn, do đó tác dụng riêng lẻ của amoxicillin không hiệu lực trên các vi khuẩn tạo ra các enzym này.

Clavulanic acid là một phiên bản beta-lactam có cấu trúc tương tự penicillin. Nó làm ngưng hoạt động một số enzym beta-lactamase, do đó ngăn cản việc mất tác dụng của amoxicillin. Clavulanic acid khi sử dụng đơn lẻ không có bất kỳ tác dụng kháng khuẩn hữu ích trên lâm sàng.

Dược lực học/Dược động học

Thời gian trên nồng độ ức chế ($T > MIC$) tối thiểu được coi là yếu tố quyết định quan trọng về hiệu quả amoxicillin.

Cơ chế đề kháng

Có hai cơ chế chính của sự đề kháng với amoxicillin/clavulanic acid.

Ngưng hoạt động bởi những vi khuẩn có beta-lactamase không được ức chế bởi acid clavulanic bao gồm cả lớp B, C và D.

Thay đổi cơ cấu PBP, do đó làm giảm các mối quan hệ của các tác nhân kháng khuẩn trên mục tiêu.

Tính không thấm nước của thành tế bào vi khuẩn hoặc cơ chế trao đổi ra bên ngoài có thể gây ra hoặc góp phần vào sức đề kháng của vi khuẩn, đặc biệt là vi khuẩn Gram âm.

Giá trị ngưỡng

Các giá trị ngưỡng MIC trên lâm sàng cho amoxicillin/clavulanic đã được xác định bởi Ủy ban châu Âu trong các thử nghiệm tính nhạy cảm của kháng khuẩn (EUCAST):

Vi sinh vật	Giá trị giới hạn nhạy cảm ($\mu g/ml$) ¹		
	Nhạy cảm	Trung bình ²	Đề kháng
<i>Haemophilus influenzae</i> ¹	≤ 1	-	> 1

<i>Klebsiella pneumoniae</i> <i>Proteus mirabilis</i> <i>Proteus vulgaris</i>
Vi sinh vật đã đề kháng
Vi sinh vật hiếu khí Gram âm
<i>Acinetobacter sp.</i> <i>Citrobacter freundii</i> <i>Enterobacter sp.</i> <i>Legionella pneumophila</i> <i>Morganella morganii</i> <i>Providencia spp.</i> <i>Pseudomonas sp.</i> <i>Serratia sp.</i> <i>Stenotrophomonas maltophilia</i>
Vi sinh vật khác
<i>Chlamydophila pneumoniae</i> <i>Chlamydophila psittaci</i> <i>Coxiella burnetii</i> <i>Mycoplasma pneumoniae</i>
§ Nhạy cảm trung gian tự nhiên và không có cơ chế khả năng đề kháng £ Tất cả các chủng Staphylococci đề kháng methicillin kháng amoxicillin/clavulanic acid. ¹ Công thức này của amoxicillin/clavulanic acid không nên sử dụng trong điều trị các bệnh nhiễm khuẩn gây ra bởi <i>Streptococcus pneumoniae</i> mà đề kháng với penicillin ² Sự xuất hiện của chủng giảm nhạy cảm đã được báo cáo ở một số nước UE trong hơn 10% các chủng.

14. Đặc tính dược động học

Hấp thu:

Amoxicillin và clavulanic acid phân ly hoàn toàn trong dung dịch nước trong phạm vi pH sinh lý.

Cả hai thành phần này được nhanh chóng và hấp thu tốt sau khi uống. Sự hấp thu của amoxicillin và acid clavulanic được tối ưu hóa khi chúng được uống vào lúc bắt đầu bữa ăn. Sau khi uống, amoxicillin và clavulanic acid đạt sinh khả dụng khoảng 70%. Và thời gian để cả 2 thành phần này đạt nồng độ đỉnh trong huyết tương (T_{max}) là tương tự nhau, khoảng 1 giờ. Nồng độ amoxicillin và acid clavulanic đạt được sau khi uống phối hợp amoxicillin + acid clavulanic là tương tự như khi uống liều amoxicillin và acid clavulanic riêng lẻ.

Phân bố:

Tính trên tổng nồng độ thuốc trong huyết tương, khoảng 25% acid clavulanic và 18% amoxicillin gắn kết với protein. Thể tích phân bố là khoảng 0,3 – 0,4 l/kg đối với amoxicillin và khoảng 0,2 l/kg acid clavulanic. Sau khi tiêm tĩnh mạch, amoxicillin và acid clavulanic được phát hiện trong túi mật, mô bụng, da, mô mỡ, cơ bắp, hoạt dịch, dịch ổ bụng, mật và mủ. Amoxicillin xâm nhập hoàn toàn vào dịch não tủy. Các nghiên cứu trên động vật đã không cung cấp bất kỳ bằng chứng nào về sự lưu trữ đáng kể của bất kỳ dẫn xuất nào của thành phần thuốc tại các mô. Amoxicillin cũng giống như hầu hết các kháng sinh penicillin, có thể được tìm thấy trong sữa mẹ. Một lượng nhỏ acid clavulanic cũng có thể được tìm thấy trong sữa mẹ. Cả amoxicillin và acid clavulanic đã được chứng minh là qua được hàng rào nhau thai.

Chuyển hóa:

Amoxicillin một phần đào thải qua nước tiểu dưới dạng penicillin không hoạt động với lượng tương đương với 10-25% liều amoxicillin ban đầu. Ở người,

<i>Moraxella catarrhalis</i> ¹	≤1	-	>1
<i>Staphylococcus aureus</i> ²	≤2	-	>2
Coagulase-negative staphylococci ²	≤0,25	-	>0,25
<i>Enterococcus</i> ¹	≤4	8	>8
<i>Streptococcus A,B,C,G</i> ⁵	≤0,25	-	>0,25
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ³	≤0,5	1-2	>2
Enterobacteriaceae ^{1,4}	-	-	>8
Bacteria ² kỵ khí Gram-âm	≤4	8	>8
Bacteria ² kỵ khí Gram-dương	≤4	8	>8
Giá trị MIC không liên quan đến các loài	≤2	4-8	>8

1. Các giá trị báo cáo liên quan đến nồng độ Amoxicillin. Để thử nghiệm tính nhạy cảm, nồng độ acid clavulanic đã được cố định ở mức 2 mg/l
2. Các giá trị báo cáo có liên quan đến nồng độ oxacillin.
3. Giới hạn giá trị được trình bày trong bảng dựa trên các giá trị giới hạn ampicillin.
4. Giá trị giới hạn cho các chủng kháng thuốc của R>8 mg/l đảm bảo rằng tất cả các chủng phân lập với cơ chế đề kháng được báo cáo bằng thuốc.
5. Giới hạn giá trị trong bảng được dựa trên các giá trị giới hạn benzylpenicillin.

Độ nhạy cảm vi sinh:

Tỷ lệ đề kháng mắc phải có thể thay đổi về mặt địa lý và thời gian đối với các loại sau và thông tin của việc đề kháng tại các khu vực là cần thiết, đặc biệt khi điều trị nhiễm khuẩn nặng. Khi cần thiết, cần tham khảo các chuyên gia về tỷ lệ đề kháng trong khu vực ở những nơi mà việc áp dụng điều trị với một vài loại nhiễm khuẩn vẫn còn chưa rõ ràng.

Những loại nhạy cảm	
<u>Vi sinh vật hiếu khí Gram dương</u>	
<i>Enterococcus faecalis</i>	
<i>Gardnerella vaginalis</i>	
<i>Staphylococcus aureus</i> (methicillin-nhạy cảm) £	
<i>Streptococcus agalactiae</i>	
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ¹	
<i>Streptococcus pyogenes</i> và các streptococci beta tan máu khác	
Nhóm <i>Streptococcus viridans</i>	
<u>Vi sinh vật hiếu khí Gram âm</u>	
<i>Capnocytophaga spp.</i>	
<i>Eikenella corrodens</i>	
<i>Haemophilus influenzae</i> ²	
<i>Moraxella catarrhalis</i>	
<i>Pasteurella multocida</i>	
<u>Vi sinh vật kỵ khí</u>	
<i>Bacteroides fragilis</i>	
<i>Fusobacterium nucleatum</i>	
<i>Prevotella spp.</i>	
Chủng có kháng năng kháng khuẩn	
<u>Vi sinh vật hiếu khí Gram dương</u>	
<i>Enterococcus faecalis</i> \$	
<u>Vi sinh vật hiếu khí Gram âm</u>	
<i>Escherichia coli</i>	
<i>Klebsiella oxytoca</i>	

acid clavulanic được chuyển hóa rộng rãi và thanh lọc qua phân và nước tiểu, như carbon dioxid được bài tiết quá hơi thở.

Thải trừ:

Amoxicillin được thải trừ chủ yếu qua thận, còn acid clavulanic là qua thận và các đường khác.

Thời gian bán thải trung bình của amoxicillin/acid clavulanic là gần 1 giờ, và có nghĩa là thời gian thanh thải khoảng 25 l/giờ ở người khỏe mạnh. Taromentin được bài tiết chủ yếu trong nước tiểu (amoxicillin-bài tiết qua cầu ống, acid clavulanic lọc qua cầu thận) và một lượng nhỏ trong phân. Sau khi dùng một liều duy nhất cho các đối tượng có chức năng thận bình thường, 50-73% amoxicillin và khoảng 25% đến 45% acid clavulanic được bài tiết dưới dạng không biến đổi trong nước tiểu sau 6-8 giờ.

Sử dụng đồng thời probenecid làm chậm bài tiết amoxicillin, nhưng không làm chậm bài tiết qua thận của acid clavulanic.

Độ tuổi

Thời gian bán thải của amoxicillin ở trẻ em từ 3 đến 2 tháng tuổi không khác ở trẻ lớn hơn và người lớn. Đối với trẻ nhỏ (bao gồm cả trẻ sơ sinh non) trong tuần đầu tiên dùng thuốc không nên dùng nhiều hơn hai lần mỗi ngày do đường thận bài tiết còn yếu. Bệnh nhân cao tuổi có nhiều khả năng đã giảm chức năng thận, do đó cần phải chăm sóc để theo dõi chức năng thận.

Giới tính

Đối với nam nữ khỏe mạnh sau khi uống amoxicillin/acid clavulanic, không có tác động đáng kể của giới tính trên được động học của amoxicillin hoặc acid clavulanic.

Suy thận

Tổng thanh thải trong huyết thanh của amoxicillin/ acid clavulanic giảm tương ứng với độ giảm của chức năng thận. Sự giảm thanh thải thuốc với amoxicillin thấy nhiều hơn so với acid clavulanic, vì tỉ lệ amoxicillin được đào thải qua thận lớn hơn. Bệnh nhân suy thận nên cân nhắc dùng liều dùng để ngăn ngừa sự tích lũy không mong muốn của amoxicillin và vẫn duy trì đủ lượng acid clavulanic cần thiết.

Suy gan

Bệnh nhân suy gan nên được theo dõi liều lượng một cách thận trọng và cần giám sát chức năng gan đều đặn.

15. Quy cách đóng gói

Hộp 1 lọ chứa 6,3 g bột hoặc 12,6 g bột hoặc 25,2 g bột. Sau khi pha thành hỗn dịch với nước, thu được tương ứng 35 ml hoặc 70 ml hoặc 140 ml hỗn dịch. Tất cả các quy cách đóng gói đều bao gồm một thìa đong để có thể lấy ra chính xác 1,25ml, 2,5ml hoặc 5ml hỗn dịch. Lọ 6,3 g và 12,6 g bột pha hỗn dịch có chứa thêm một bơm tiêm cho phép lấy đến 5 ml hỗn dịch với độ chính xác 0,1ml.

16. Điều kiện bảo quản, hạn dùng, tiêu chuẩn chất lượng

Điều kiện bảo quản:

Lọ bột khô: bảo quản ở nhiệt độ không quá 30°C, tránh ẩm.

Hỗn dịch sau khi pha: bảo quản trong tủ lạnh (2°C-8°C), dùng trong vòng 7 ngày sau khi pha.

Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn chất lượng: Nhà sản xuất.

17. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất thuốc

Sản xuất tại Ba Lan bởi:

Tarchomin Pharmaceutical Works "Polfa" S.A.
2, A. Fleminga str., 03-176 Warsaw, Poland.